

골반장기탈출증(pelvic organ prolapse) 수술을 고려 중이시라면, 집도의와 함께 여러 가지 사항을 결정해야 합니다. 대부분의 경우 단 하나의 “정답”은 없으며 — 최선의 계획은 해부학적 구조, 건강 상태, 그리고 무엇을 가장 중요하게 생각하시는데 따라 달라집니다. 이 안내문은 충분한 정보를 바탕으로 대화를 나눌 수 있도록 주요 결정 사항들을 정리한 것입니다.

주요 결정 사항

- **복원 vs. 폐쇄** — 지지 구조를 재건하여 질을 유지하는 재건 수술, 또는 질 성교를 계획하지 않는 경우 질을 막는 폐쇄 수술(질폐쇄술, colpocleisis).
- **수술 경로** — 질식 접근(vaginal route) 또는 복부 접근(abdominal route, 복강경/로봇 수술).
- **자궁** — 자궁 적출(자궁절제술) 또는 자궁을 보존하는 현수술(자궁고정술, hysteropexy).
- **지지 소재** — 자가 조직(native tissue) 복원, 생물학적 이식편, 또는 메시(mesh, 복부 경로의 경우).
- **요실금** — 항요실금 시술을 동시에 시행할지 여부(아래 참조).

숨어 있는 요실금에 대하여

탈출증이 심한 경우, 수술 후에만 나타나는 복합성 요실금이 **가려져** 있을 수 있습니다(“잠재성” SUI). 의료진이 이를 검사한 뒤, 동시에 슬링(sling) 시술을 추가할지 또는 기다릴지 논의할 수 있습니다.

용어 설명

재건적(Reconstructive)

지지 구조를 재건하여 질 기능을 유지하는 수술.

폐쇄적(Obliterative)

질을 막는 수술(질폐쇄술) — 내구성이 높으나 성교 불가.

자궁고정술(Hysteropexy)

자궁을 보존하면서 현수하는 수술.

자가 조직 복원

이식편 없이 본인의 조직만 사용하는 복원.

잠재성 SUI

탈출증 교정 후 나타나는 숨어 있던 복합성 요실금.

재발(Recurrence)

시간이 지나면서 탈출증이 다시 생길 가능성.

어떻게 선택하나요? 본인의 우선순위에 맞는 옵션을 선택하세요 — 내구성, 회복 기간, 자궁 보존 여부, 성생활, 메시에 대한 입장 등을 고려하세요. 집도의가 해부학적 구조와 건강 상태에 맞는 방법을 권장할 것이며, “최선의” 옵션은 충분한 대화 후 본인의 목표에 부합하는 것입니다.

집도의에게 질문할 사항

- 저에게 어떤 **수술(들)**을 권장하시나요, 그 이유는 무엇인가요?
- **질식 또는 복부** 경로 — 각각의 회복 과정은 어떻게 되나요?
- **자궁을 보존**할 수 있나요(또는 보존해야 하나요)?
- **자가 조직, 이식편, 메시** 중 무엇을 사용하나요 — 각각의 위험은 무엇인가요?
- 지금 또는 나중에 **항요실금** 시술이 필요한가요?
- **재발** 가능성은 어느 정도이며, 재발하면 어떻게 되나요?

알아두면 좋은 정보

- 수술을 피하거나 미루고 싶다면 **페서리(pessary)**가 항상 비수술적 대안입니다.
- 체중 관리, 변비·기침 치료, 폐경 후 질 에스트로겐 사용은 수술 결과를 향상시킬 수 있습니다.

준비 방법

- **수술 전 검사**를 완료하고, 복용 중인 약 목록을 지참하세요.
- **금연**하고 귀가 후 도움을 받을 수 있도록 준비하세요.
- 일반적으로 약 6주간 무거운 물건 들기와 성생활을 삼가야 합니다.

수술 전 의료진에게 알려주세요:

- **혈액 희석제** 복용 중이거나 출혈 문제가 있는 경우
- 현재 요로 또는 질 **감염**이 있는 경우
- 새로운 골반 **통증, 출혈, 또는 탈출 부위에 낫지 않는 상처**가 있는 경우

기억할 세 가지

1. 탈출증 수술에는 여러 선택이 있습니다 — 복원 vs. 폐쇄, 경로, 자궁 보존 여부, 지지 소재, 잠재성 요실금 치료 여부.
2. 정답은 드물게 하나뿐입니다. 최선의 계획은 해부학적 구조와 본인의 우선순위에 맞는 것입니다.
3. 핵심 질문을 하고, 페서리는 언제나 비수술적 대안임을 기억하세요.